

TEMA 1.10 • PEDIATRÍA

Muerte Súbita del Lactante y ALTE

PERFIL EUNACOM 2.01.2.017

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Muerte Súbita del Lactante y ALTE

1. Muerte Súbita del Lactante

Definición: Muerte de un lactante durante el sueño, sin causa aparente, con autopsia **normal**.

Edad más frecuente: 2–6 meses de vida.

NOTA CLÍNICA

La causa #1 de muerte en el primer mes son los problemas de prematuridad y malformaciones. Después del primer mes, la muerte súbita es la causa más frecuente de muerte en lactantes (aunque es rara: ~1/1.000).

Factores de Riesgo

TABLA 1.10.1: FACTOR DE RIESGO VS IMPORTANCIA

FACTOR DE RIESGO	IMPORTANCIA
Prematuridad	Mayor factor de riesgo (aumenta el riesgo ~30 veces)
Tabaquismo, alcoholismo, drogas maternas	Alto riesgo
Dormir en prono (boca abajo)	Muy importante
Co-lecho (dormir en la misma cama)	Riesgo moderado
Antecedente familiar de muerte súbita	Relevante
Ausencia de lactancia materna	Factor de riesgo
Sexo masculino	60% de los casos

Prevención (Lo Más Importante)

- **Lactancia materna** (factor protector)
- Posición para dormir: **decúbito supino (boca arriba)** — nunca en prono
- Cuna propia en la misma habitación que los padres (no co-lecho ni habitación separada)
- Evitar peluches, almohadas, frazadas sueltas en la cuna
- No fumar en la casa

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla de oro: La guagua duerme **boca arriba, en su propia cuna, en la misma habitación** que los padres.

Si hay co-lecho: Debe ser en guagua sin factores de riesgo, con dispositivo especial tipo "moisés dentro de la cama", sin alcohol/pastillas, sin otros niños, sin frazadas sueltas.

2. ALTE (Apparent Life-Threatening Event)

Evento que Aparentemente Amenaza la Vida

- **Clínica:** Evento agudo presenciado por un cuidador que asusta:
- **Apnea** (deja de respirar)
- **Cambio de color:** cianosis o palidez grisácea
- **Hipotonía** brusca (queda "flácido")

Clasificación: Alto vs. Bajo Riesgo

TABLA 1.10.2: CRITERIO VS ALTE ALTO RIESGO

CRITERIO	ALTE ALTO RIESGO	ALTE BAJO RIESGO
Edad	< 6 meses	> 6 meses (incluso > 1 año)
Prematuridad	Sí	No
Factores de riesgo asociados	Sí (antecedente familiar MS, etc.)	No
Requirió RCP para recuperar	Sí	No (se recuperó espontáneamente)
Examen físico	Alterado	Normal

Manejo ALTE de Alto Riesgo

- **Hospitalización** - Exámenes: infectológicos, ECG (descartar QT largo), monitoreo de apneas, pH-metría (descartar RGE) - **Monitor de apneas domiciliario** (no reduce mortalidad pero está indicado; genera ansiedad) - **Enseñar RCP a los padres**

Manejo ALTE de Bajo Riesgo

- **Tranquilizar y educar** - Si hay **apnea emotiva**: es benigna, sin secuelas - Ocurre con frustración/emoción intensa → niño llora → apnea → cianosis → recuperación espontánea - Conducta: educar sobre tolerancia a la frustración; no es urgencia

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El monitor de apneas domiciliario **NO disminuye la mortalidad por muerte súbita**. Solo está indicado en ALTE de alto riesgo o antecedente familiar de muerte súbita. No indicarlo en lactantes sanos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Madre consulta porque su hijo de 3 meses estaba durmiendo en posición prona y lo encontró cianótico y sin respirar. Comenzó a respirar al estimularlo. Nació a término, sin antecedentes. Es el primer episodio. ¿Cuál es la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Muerte Súbita del Lactante y ALTE. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- SMSL: muerte inesperada <1 año sin causa tras autopsia; pico 2-6 meses; dormir supino previene
- Factores de riesgo SMSL: prono, tabaquismo en hogar, colecho, colchón blando, temperatura excesiva
- ALTE: apnea ≥20 seg o con cianosis/palidez/hipotonía/bradicardia; requiere evaluación diagnóstica
- ALTE alto riesgo: <1 mes, prematuro, ≥2 episodios, necesitó reanimación → hospitalizar siempre
- ALTE bajo riesgo: >1 mes, término, primer episodio, se recuperó solo → alta con monitor opcional
- Apnea emotiva (espasmo del sollozo): llanto → apnea → pérdida de conciencia; benigno, 6m-5 años

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE Y ALTE)

PREGUNTA 1

Madre consulta porque su hijo de 3 meses estaba durmiendo en posición prona y lo encontró cianótico y sin respirar. Comenzó a respirar al estimularlo. Nació a término, sin antecedentes. Es el primer episodio. ¿Cuál es la conducta?

- ☐ A) Alta con instrucciones de posición supina para dormir
- ☐ B) Hospitalizar para evaluación diagnóstica y monitorización
- ☐ C) Alta con monitor cardiorrespiratorio domiciliario
- ☐ D) RCP inmediata en urgencias aunque ya esté reactivo
- ☐ E) Educación sobre tabaquismo pasivo y control en 1 semana

PREGUNTA 2

Para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es INCORRECTA?

- ☐ A) Colocar al lactante boca arriba (supino) para dormir
- ☐ B) Compartir la cama con los padres (colecto) para facilitar lactancia nocturna
- ☐ C) Evitar tabaquismo en el ambiente del lactante
- ☐ D) Usar colchón firme y retirar almohadas o peluches del lugar de sueño
- ☐ E) Mantener temperatura ambiental entre 20-22°C

PREGUNTA 3

Niño de 18 meses presenta episodios repetidos en los que, tras frustrarse o golpearse, llora fuertemente, luego deja de respirar, se pone pálido y pierde el conocimiento brevemente, recuperándose solo. Sin ictericia, sin fiebre. Examen neurológico normal. ¿Cuál es el diagnóstico?

- ☐ A) Epilepsia de ausencia
- ☐ B) ALTE recurrente
- ☐ C) Síncope vasovagal
- ☐ D) Apnea emotiva (espasmo del sollozo)
- ☐ E) Crisis hipóxico-isquémica cerebral

RESUMEN: MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE Y ALTE

La causa #1 de muerte en el primer mes son los problemas de prematuridad y malformaciones. Después del primer mes, la muerte súbita es la causa más frecuente de muerte en lactantes (aunque es rara: ~1/1.000).
::: 1. Lactancia materna (factor protector) 2. Posición para dormir: decúbito supino (boca arriba) — nunca en prono 3. Cuna propia en la misma habitación que los padres (no colecto ni habitación separada) 4. Evitar peluches, almohadas, frazadas sueltas en la cuna 5. No fumar en la casa
:::tip Regla de oro: La guagua duerme boca arriba, en su propia cuna, en la misma habitación que los padres. :::